EMT-1 教材概念自編練習（非考古題）

有解析版 ｜ 共 96 題

題目	選項與法規解析	答案
001. 依現行《救護技術員管理辦法》（民國 114 年 1 月 1 日施行）附表一，初級救護技術員訓練課程的總時數是幾小時？	(A) 24 小時 (B) 40 小時 (C) 48 小時 (D) 56 小時 【解析】《救護技術員管理辦法》第3條：各級救護技術員之訓練課程模組別、科目別、內容及時數如附表一至附表三。附表一「初級救護技術員訓練課程基準」共七個模組，總時數 56 小時。修正前為 40 小時，舊教材與歷屆考古題多以 40 小時作答。 參考：救護技術員管理辦法 第3條	(D)
002. 依《救護技術員管理辦法》，初級救護技術員證書的有效期間是幾年？	(A) 3 年 (B) 4 年 (C) 5 年 (D) 6 年 【解析】《救護技術員管理辦法》第9條：各級救護技術員證書有效期間為三年。 參考：救護技術員管理辦法 第9條	(A)
003. 依現行《救護技術員管理辦法》，初級救護技術員在證書效期三年內要完成多少繼續教育課程，才能申請展延？	(A) 16 小時以上，其中 8 小時為模組二、四及六之科目 (B) 24 小時以上，其中 12 小時為模組二、四及六之科目 (C) 32 小時以上，其中 16 小時為模組二、四及六之科目 (D) 40 小時以上，其中 20 小時為模組二、四及六之科目 【解析】《救護技術員管理辦法》第10條：初級救護技術員完成附表一所列科目達二十四小時以上，且其中十二小時以上為模組二、四及六之科目，得申請證書效期之展延；展延之有效期間每次為三年。 參考：救護技術員管理辦法 第10條	(B)
004. 依《救護技術員管理辦法》第13條，下列何者屬於初級救護技術員得施行之救護項目？	(A) 使用聲門上呼吸道維持呼吸 (B) 建立周邊血管路徑並給予輸液 (C) 依預立醫療流程施行氣管插管 (D) 使用自動體外心臟電擊去顫器 【解析】《救護技術員管理辦法》第13條列出初級救護技術員得施行的 20 項救護項目，第14款為「使用自動體外心臟電擊去顫器」。周邊輸液與注射用輸液屬中級項目（第14條）；依預立醫療流程給藥、氣管插管屬高級項目（第15條）。 參考：救護技術員管理辦法 第13條	(D)
005. 依《緊急醫療救護法》第34條，救護紀錄表應由救護車設置機關（構）及應診之醫療機構保存至少幾年？	(A) 1 年 (B) 3 年 (C) 5 年 (D) 7 年 【解析】《緊急醫療救護法》第34條：救護人員施行救護，應填具救護紀錄表，分別交由該救護車設置機關（構）及應診之醫療機構保存至少七年。 參考：緊急醫療救護法 第34條	(D)
006. 依《緊急醫療救護法》第14-2條，救護人員以外之人為免除他人生命之急迫危險而施予急救措施，法律責任如何處理？	(A) 傷病患死亡時仍應負過失致死罪責 (B) 適用民法、刑法緊急避難免責之規定 (C) 僅於傷病患為直系血親時得以免責 (D) 僅免除行政責任，民事與刑事仍須負責 【解析】《緊急醫療救護法》第14-2條：救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之。 參考：緊急醫療救護法 第14-2條	(B)

題目	選項與法規解析	答案
007. 救護技術員無故洩漏因業務知悉或持有的他人秘密，依《緊急醫療救護法》第35條及第45條的罰則為何？	(A) 處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰 (B) 處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰 (C) 處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰 (D) 處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰 【解析】《緊急醫療救護法》第35條：救護技術員及其他參與緊急醫療救護業務之機關（構）所屬人員，因業務而知悉或持有他人之秘密，不得無故洩漏。違反者依第45條第3款處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。 參考：緊急醫療救護法 第35條	(B)
008. 依《緊急醫療救護法》第29條，救護人員應將緊急傷病患送達何處？	(A) 距離最近之醫學中心 (B) 傷病患指定之醫療機構 (C) 就近適當之醫療機構 (D) 衛生局指定之責任醫院 【解析】《緊急醫療救護法》第29條：救護人員應依救災救護指揮中心指示前往現場急救，並將緊急傷病患送達就近適當醫療機構。 參考：緊急醫療救護法 第29條	(C)
009. 依《緊急醫療救護法》第18條，救護車於救護傷病患及運送病人時，至少要有幾名救護人員出勤？	(A) 救護人員一名以上 (B) 救護人員二名以上 (C) 救護人員三名以上 (D) 救護人員四名以上 【解析】《緊急醫療救護法》第18條：救護車於救護傷病患及運送病人時，應有救護人員二名以上出勤；加護救護車出勤之救護人員，至少應有一名為醫師、護理人員或中級以上救護技術員。 參考：緊急醫療救護法 第18條	(B)
010. 病患意識清醒且具有完全行為能力，但堅決拒絕救護人員處置與送醫，救護員的適當處置為何？	(A) 說明風險並記錄其拒絕意願 (B) 約束病患後強制送往醫院 (C) 通報警察到場後強制帶離 (D) 不作說明直接收隊離開現場 【解析】具有完全決定能力之成年病患享有拒絕醫療自主權。救護員應耐心溝通、充分說明未就醫之后續風險，若病患仍堅持拒絕，應請其簽署「拒絕緊急醫療處置/送醫聲明書」並登載於救護紀錄表，以昭信守並保障雙方權益。 參考：內政部消防署 – 緊急救護作業程序規範	(A)
011. 救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，關於行駛的規定，下列敘述何者錯誤？	(A) 得不受標誌、標線及號誌之限制 (B) 得不受行車速度之限制 (C) 肇事時得免除刑事與民事責任 (D) 仍應注意其他車輛及行人安全 【解析】《道路交通安全規則》第93條第2項：消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。 條文只免除速限與標誌、標線、號誌的限制，沒有免除肇事責任的規定，所以「完全免除刑事與民事責任」的敘述沒有依據。「仍應注意其他車輛及行人安全」這項注意義務不在這一條的文字裡，本題保留歷屆答案，不列入模擬考。 參考：道路交通安全規則 第93條	(C)
012. 依現行《救護技術員管理辦法》，協助使用吸入型支氣管擴張劑、自備腎上腺素注射筆或硝化甘油舌下含片，最低須為哪一級救護技術員才得施行？	(A) 初級救護技術員 (B) 中級救護技術員 (C) 高級救護技術員 (D) 各級均不得施行 【解析】《救護技術員管理辦法》第14條第5款把「協助使用吸入型支氣管擴張劑、自備腎上腺素注射筆或硝化甘油舌下含片」列為中級救護技術員得施行之項目；第13條所列初級救護技術員的 20 項救護項目不包含這一項。 參考：救護技術員管理辦法 第14條	(B)

題目	選項與法規解析	答案
013. 下列何者不屬於救護常規所稱的生命徵象？	(A) 瞳孔 (B) 膚色 (C) 尿量 (D) 體溫 【解析】緊急救護實務之八大生命徵象包含：1.意識、2.呼吸、3.脈搏、4.血壓、5.體溫、6.瞳孔、7.膚色與體溫濕度、8.微血管充填時間(CRT)及血氧飽和度(SpO2)。體重與尿量屬於院內長期監測指標，非院前八大生命徵象。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 病患評估章節	(C)
014. 健康成年人安靜休息時，正常脈搏是每分鐘幾次？	(A) 60～100 次 (B) 80～120 次 (C) 100～140 次 (D) 120～160 次 【解析】正常成年人安靜時脈搏正常值為 60～100 次/分。小於 60 次/分為心搏過緩，大於 100 次/分為心搏過速。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 生命徵象數值標準	(A)
015. 健康成年人安靜休息時，正常呼吸是每分鐘幾次？	(A) 6～10 次 (B) 8～12 次 (C) 12～20 次 (D) 20～30 次 【解析】成年人平靜呼吸頻率正常值約為 12～20 次/分。小於 10～12 次/分常代表換氣不足；大於 20～24 次/分為呼吸過速；大於 30 次/分常被列為檢傷重症危急指標。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 呼吸系統與評估	(C)
016. 格拉斯哥昏迷指數評估哪三個面向？滿分與最低分各是幾分？	(A) 睜眼、語言、瞳孔；滿分 12 分，最低 3 分 (B) 睜眼、語言、動作；滿分 15 分，最低 0 分 (C) 瞳孔、語言、動作；滿分 15 分，最低 3 分 (D) 睜眼、語言、動作；滿分 15 分，最低 3 分 【解析】GCS 昏迷指數由睜眼反應（Eye, 1-4分）、語言反應（Verbal, 1-5分）、動作反應（Motor, 1-6分）三者組成。滿分為 15 分（完全清醒正常），最低分為 3 分（對任何刺激均無反應的深昏迷）。 參考：台灣急診醫學會 - GCS評估指引	(D)
017. 病患對呼喚沒有反應，給予痛刺激時能準確抬手撥開痛源，昏迷指數的動作反應應評為幾分？	(A) 2 分 (B) 3 分 (C) 4 分 (D) 5 分 【解析】GCS 動作反應（M）計分：M6 遵從口頭指令；M5 對疼痛能「定位並撥開痛源」；M4 僅能縮回退縮避痛；M3 異常屈曲；M2 異常伸展；M1 完全無動作反應。 參考：Dcard 265T 快速參考手冊 - GCS評估速查表	(D)
018. 傷患經叫喚才睜眼（E3）、只能說出不成句的單字（V3）、對痛刺激只有肢體縮回（M4），昏迷指數總分是幾分？	(A) 9 分 (B) 10 分 (C) 11 分 (D) 12 分 【解析】總分 = E (3) + V (3) + M (4) = 10 分。臨床上 GCS ≦ 8 分通常定義為嚴重腦傷或重度昏迷，呼吸道極易阻塞，常需積極呼吸道處置。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 神經學評估	(B)
019. 評估微血管充填時間時，正常應在幾秒內恢復血色？	(A) 2 秒 (B) 3 秒 (C) 4 秒 (D) 5 秒 【解析】輕壓指甲床或皮膚使其變白後放開，正常應於「2 秒以內」迅速恢復粉紅。若 CRT ＞ 2 秒，代表末梢組織微血管血液灌流不足，常為休克、脫水、低體溫或周邊循環障礙之早期徵兆。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 循環評估	(A)

題目	選項與法規解析	答案
020. 評估意識清醒且呼吸正常的成年傷病患時，通常優先觸摸哪一條動脈的脈搏？	(A) 股動脈 (B) 頸動脈 (C) 橈動脈 (D) 肱動脈 【解析】對於意識清楚且有呼吸之成人病患，首選以手腕拇指側之「橈動脈」評估脈搏強度、速率與規則度；無意識或休克瀕死病患才優先摸「頸動脈」。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 生命徵象量測技術	(C)
021. 成人突然倒地、呼喚無反應且沒有呼吸，救護員應在幾秒內觸摸哪一條動脈確認脈搏？	(A) 30 秒內觸摸頸動脈 (B) 10 秒內觸摸頸動脈 (C) 10 秒內觸摸橈動脈 (D) 30 秒內觸摸橈動脈 【解析】評估無反應無呼吸成人時，救護員應在「5 至 10 秒內」觸摸「頸動脈（氣管軟骨旁溝槽）」。若 10 秒內無法確認脈搏，應立即視同無脈搏心搏驟停，立刻實施 CPR 胸外按壓。 參考：AHA 2020 心肺復甦術指引 / 消防署教材	(B)
022. 評估未滿一歲嬰兒的脈搏時，建議觸摸哪一條動脈？	(A) 橈動脈 (B) 肱動脈 (C) 顳動脈 (D) 頸動脈 【解析】嬰兒頸部通常較短且脂肪豐厚，觸摸頸動脈困難且易壓迫呼吸道，因此一歲以下嬰兒建議觸摸上臂內側之「肱動脈（或股動脈）」。 參考：AHA 兒童高級救命指引 / 消防署教材	(B)
023. 檢查瞳孔時發現兩側大小不等，其中一側放大且對光沒有反應，最可能代表什麼狀況？	(A) 低血糖反應 (B) 有機磷中毒 (C) 顱內壓升高 (D) 鴉片類中毒 【解析】兩側瞳孔大小不等超過 1mm 且對光反射遲鈍或無反應，多為嚴重顱內損傷、硬腦膜上/下出血導致第三對腦神經（動眼神經）受壓迫之腦疝危急徵兆。鴉片中毒通常為雙側極度針尖樣縮小。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 神經學評估	(C)
024. 成人收縮壓低於多少毫米汞柱時，通常視為低血壓或休克的警訊？	(A) 70 (B) 80 (C) 90 (D) 100 【解析】收縮壓 ＜ 90 mmHg（或平均動脈壓 MAP ＜ 65 mmHg）為休克評估之重要切點，代表心血管循環無法維持重要器官之基本血液灌流需求。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 休克評估	(C)
025. 調控呼吸、心跳與血管張力等基本生命機能的「生命中樞」，位於中樞神經系統的哪個部位？	(A) 大腦 (B) 腦幹 (C) 小腦 (D) 脊髓 【解析】延腦與橋腦位於腦幹，內含心血管中樞與呼吸節律中樞，調節生命呼吸心跳反射，被稱為生命中樞。此處受損常致命。 參考：初級救護技術員訓練教材 - 解剖生理學基礎	(B)
026. 簡易意識評估 AVPU 中的 P 代表什麼？	(A) 對痛刺激有反應 (B) 對聲音有反應 (C) 對刺激沒有反應 (D) 清醒可以對答 【解析】AVPU 量表：A = Alert（警醒清醒）；V = Responds to Voice（對聲音有反應）；P = Responds to Pain（僅對疼痛有反應）；U = Unresponsive（無任何反應）。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 意識初評快速量表	(A)

題目	選項與法規解析	答案
027. 懷疑頸椎受傷的病患，暢通呼吸道應優先採用哪一種徒手方法？	(A) 頸部後仰法 (B) 推下顎法 (C) 壓額抬頦法 (D) 頭部側轉法 【解析】創傷傷患必須保護頸椎，嚴禁將頭部後仰，應使用「推下顎法」，雙手托住下頜骨角向前上方抬起，使舌根脫離呼吸道後壁，避免加劇脊椎損傷。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 呼吸道處置	(B)
028. 口咽呼吸道的尺寸怎麼量？	(A) 嘴角到耳垂 (B) 鼻尖到耳垂 (C) 嘴角到喉結 (D) 鼻尖到嘴角 【解析】口咽呼吸道（OPA）之正確尺寸測量方法為：將翼板置於病患「嘴角」，末端恰好對準病患同側「耳垂」或「下頜角」。太長會刺激會厭引發喉部痙攣，太短則會將舌根往後推壓加重阻塞。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 人工呼吸道量測	(A)
029. 口咽呼吸道適用於哪一種病患？	(A) 意識清醒但是咳嗽無力 (B) 意識清醒而且呼吸急促 (C) 意識不清但是仍有嘔吐反射 (D) 意識不清而且沒有嘔吐反射 【解析】口咽呼吸道適用於意識不清且沒有嘔吐反射的病患；仍有嘔吐反射時可能引起嘔吐與吸入風險。是否對疼痛刺激有反應，不能單獨取代嘔吐反射評估。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - OPA適應症與禁忌症	(D)
030. 成人口咽呼吸道凹面朝上置入後，接近軟硬顎交界時應如何操作？	(A) 旋轉 360 度後繼續置入 (B) 不旋轉，直接推到定位 (C) 旋轉 90 度後繼續置入 (D) 旋轉 180 度後繼續置入 【解析】消防署《110 年中級救護技術員教科書》電子書第 89 頁：成人口咽呼吸道凹面朝上置入，接近硬顎後旋轉 180 度再繼續置入；另可使用壓舌板輔助直接置入。本題只問前述旋轉法。 參考：消防署《110 年中級救護技術員教科書》，電子書第 89 頁	(D)
031. 鼻咽呼吸道的長度怎麼量？	(A) 鼻尖到嘴角 (B) 鼻尖到喉結 (C) 鼻尖到耳垂 (D) 嘴角到耳垂 【解析】鼻咽呼吸道（NPA）長度量測方式為：從「病患鼻尖量至同側耳垂（或下頜角）」；外徑管徑大小通常約相當於病患本人的小指直徑粗細。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - NPA測量標準	(C)
032. 下列哪一種情況不可使用鼻咽呼吸道？	(A) 懷疑頸椎受傷 (B) 牙關緊閉不開 (C) 仍有嘔吐反射 (D) 懷疑顱底骨折 【解析】顱底骨折患者若置入 NPA，導管可能穿透碎裂的篩骨板直接插進顱內腦組織，造成致死性腦損傷，因此為絕對禁忌症！ 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - NPA禁忌症	(D)
033. 為成人抽吸口咽部的分泌物時，單次抽吸時間最長不可超過幾秒？	(A) 5 秒 (B) 10 秒 (C) 15 秒 (D) 20 秒 【解析】抽吸會同時抽除口咽內氣體造成嚴重缺氧並可能刺激迷走神經引發心搏過緩。成人單次抽吸時間上限為「15 秒」（小兒為 10 秒，嬰兒為 5 秒）。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 / 歷屆鑑測真題	(C)

題目	選項與法規解析	答案
034. 使用抽吸管清除口腔分泌物時，正確的操作原則是什麼？	(A) 放到定位後，固定不動持續抽吸 (B) 放入與退出時，全程都持續抽吸 (C) 放到定位後，邊抽吸邊旋轉退出 (D) 放入時就開始抽吸，直到定位 【解析】量測長度為嘴角至耳垂。插入口腔時「不可按住通氣孔（不可抽吸）」，避免刮傷黏膜引發出血；待導管到達適當深度後，才按住通氣孔開始抽吸，並以旋轉方式平順退出。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 抽吸技術操作規範	(C)
035. 使用鼻導管給氧時，氧氣流量通常設定在每分鐘幾公升？	(A) 1～6 公升 (B) 6～10 公升 (C) 10～15 公升 (D) 15～25 公升 【解析】鼻導管建議流量為 1～6 L/min。空氣中氧氣約 21%，每增加 1 L/min 氧氣流量約增加 4% 氧濃度（1L約24%、2L約28%...6L約44%）。流量超過 6 L/min 容易造成鼻黏膜乾燥破皮流血且無法提升濃度。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 氧氣治療設備	(A)
036. 使用非再吸入型面罩給氧時，流量設定與使用前的準備何者正確？	(A) 每分鐘 10～15 公升，先把儲氣袋壓扁 (B) 每分鐘 1～6 公升，先讓儲氣袋充滿 (C) 每分鐘 1～6 公升，先把儲氣袋壓扁 (D) 每分鐘 10～15 公升，先讓儲氣袋充滿 【解析】NRM 適用於嚴重低血氧、嚴重創傷或休克病患，氧氣流量設定為 10～15 L/min（可提供 80%～90% 以上高濃度氧氣）。使用前必須先用手遮住瓣膜將儲氣袋充氣至少 2/3 以上，才能配戴於病患口鼻，避免吸入量不足。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - NRM操作重點	(D)
037. 用袋瓣罩甦醒球為沒有呼吸的成人通氣時，面罩應如何放置？	(A) 尖端朝向鼻樑，輕放面罩不必提下顎 (B) 尖端朝向鼻樑，扣緊面罩並提起下顎 (C) 尖端朝向下巴，輕放面罩不必提下顎 (D) 尖端朝向下巴，扣緊面罩並提起下顎 【解析】面罩尖端對準鼻骨鼻樑，寬端蓋住嘴唇與下巴。施救者以左手「EC 手勢」操作（拇指與食指形成 C 壓住面罩邊緣，下三指形成 E 勾住下頜骨角向前拉抬向上提），確保不漏氣。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - BVM通氣技巧	(B)
038. 袋瓣罩甦醒球接上氧氣與儲氣袋時，氧氣流量通常設定為每分鐘幾公升？	(A) 6 公升 (B) 8 公升 (C) 10 公升 (D) 15 公升 【解析】BVM 連接高壓氧氣瓶進行人工甦醒時，氧氣流量應調至最大之「15 L/min」，配合儲氣袋可提供接近 90%～100% 的純氧。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 甦醒球高濃度氧給予	(D)
039. D 型攜帶式氧氣鋼瓶的換算常數與安全殘壓各是多少？	(A) 常數 0.16，安全殘壓 500 psi (B) 常數 0.16，安全殘壓 200 psi (C) 常數 0.28，安全殘壓 200 psi (D) 常數 0.28，安全殘壓 500 psi 【解析】氧氣鋼瓶常數：D 瓶為 0.16（救護攜帶常用）、E 瓶為 0.28、M 瓶為 1.56。安全存量通常設定保留 200 psi（部分教材規範 500 psi），防止鋼瓶內氣體完全耗盡受潮。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 氧氣鋼瓶可用時間計算	(B)
040. D 型氧氣鋼瓶壓力表顯示 1200 psi（換算常數 0.16，安全殘壓 200 psi），以每分鐘 10 公升給氧，大約還能用幾分鐘？	(A) 約 8 分鐘 (B) 約 16 分鐘 (C) 約 19 分鐘 (D) 約 28 分鐘 【解析】氧氣可用時間公式：(目前壓力 − 安全存量) × 鋼瓶常數 ÷ 氧氣流量 = (1200 − 200) × 0.16 ÷ 10 = 1000 × 0.16 ÷ 10 = 160 ÷ 10 = 16 分鐘。 參考：Dcard 265T 快速參考手冊 - 氧氣計算題型解析	(B)

題目	選項與法規解析	答案
041. 成人有脈搏但呼吸不足，以袋瓣罩甦醒球給予人工呼吸時，多久給一口氣？	(A) 每 2～3 秒一次 (B) 每 6 秒一次 (C) 每 10 秒一次 (D) 每 15 秒一次 【解析】消防署 114 年《救護技術員教科書》電子書第 125 頁：成人有脈搏但需人工呼吸時，每分鐘約 10 次，約每 6 秒給氣一次；每次給氣約 1 秒並觀察胸廓起伏。 參考：消防署《救護技術員教科書》114 年版，電子書第 125 頁	(B)
042. 成人院外心臟停止生存之鏈中，高品質心肺復甦術之後接著是哪個環節？	(A) 高級心肺復甦 (B) 復甦後的照護 (C) 儘早電擊去顫 (D) 啟動緊急應變 【解析】成人院外心臟停止生存之鏈依序強調：早期辨識與求救、高品質心肺復甦術、儘早去顫、高級救命術、心臟停止後照護及復原。本題問高品質心肺復甦術後的下一環節。 參考：台灣急診醫學會 - 2020 CPR指引生存之鏈	(C)
043. 成人高品質 CPR 的按壓深度與速率各是多少？	(A) 深度 4～5 公分，每分鐘 80～100 下 (B) 深度 4～5 公分，每分鐘 100～120 下 (C) 深度 5～6 公分，每分鐘 100～120 下 (D) 深度 5～6 公分，每分鐘 80～100 下 【解析】高品質 CPR 五大要領：1. 用力壓（成人深度 5～6 公分，不超過 6 公分）；2. 快快壓（速率 100～120 次/分）；3. 胸回彈（每次按壓後完全回彈）；4. 莫中斷（按壓中斷時間小於 10 秒）；5. 避免過度通氣。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - CPR操作標準	(C)
044. 成人 CPR 不論單人或雙人施救，壓胸與人工呼吸的比例是多少？	(A) 15：1 (B) 15：2 (C) 30：1 (D) 30：2 【解析】成人 CPR 無論是單人或雙人施救，胸外按壓與吹氣循環比例均維持「30：2」（每按壓 30 次後給予 2 口氣）。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - CPR循環比例	(D)
045. 兩名救護員為兒童或嬰兒施行 CPR 時，壓胸與人工呼吸的比例是多少？	(A) 3：1 (B) 5：1 (C) 15：2 (D) 30：2 【解析】兒科/嬰兒心臟驟停通常多源於呼吸衰竭缺氧。單人施救時比例仍為 30：2；但「雙人專業救護員」時，兒童及嬰兒之按壓吹氣比應調整為「15：2」，以提高氧氣供給比例。 參考：AHA 兒科基礎救命術指引 / 消防署教材	(C)
046. AED 語音提示「建議電擊」，表示傷患的心律最可能是哪一種？	(A) 心室纖維顫動或無脈性心室頻脈 (B) 竇性心搏過緩或房室傳導阻滯 (C) 正常竇性心律或心房顫動 (D) 心搏停止或無脈性電氣活動 【解析】AED 建議電擊的主要心律是心室纖維顫動及無脈性心室頻脈。心搏停止和無脈性電氣活動不屬於可電擊心律；依設備提示持續高品質心肺復甦術。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - AED原理與心律	(A)
047. AED 顯示「不建議電擊」後，救護員應立即做什麼？	(A) 立即繼續胸外按壓 (B) 先檢查脈搏一分鐘 (C) 再按一次電擊按鈕 (D) 撕除貼片關閉電源 【解析】心搏停止（Asystole/靜態直線）及無脈性電氣活動（PEA）為「不建議電擊心律」，電擊無效甚至有害。此時應完全不中斷，立即重新接續實施高品質胸外按壓（CPR）。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - AED語音處置流程	(A)

題目	選項與法規解析	答案
048. AED 成人電擊貼片的標準黏貼位置在哪裡？	(A) 右鎖骨下方與左胸外下方 (B) 兩側鎖骨下方各貼一片 (C) 左鎖骨下方與右胸外下方 (D) 胸骨正中與左側上腹部 【解析】成人標準前側貼片位置：一塊貼於「右胸前壁鎖骨下方」，另一塊貼於「左乳頭外下方前側腋下肋骨處」，使去顫電流能穿過心臟中心。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - AED貼片黏貼位置	(A)
049. AED 充電完成、準備電擊時，按下電擊鈕前必須先確認什麼？	(A) 貼片已經撕下來 (B) 沒有人碰觸傷患 (C) 傷患已恢復脈搏 (D) 氧氣面罩已戴好 【解析】去顫電擊電流強大，若他人接觸傷患會引發觸電危險。施救者必須環顧全場大聲口誦並比畫：「我離開、你離開、大家都離開！」，確認無任何人觸碰傷患或病床後方可按下橘/紅色閃爍電擊鈕。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - AED安全鐵則	(B)
050. AED 完成電擊後，救護員應立刻做什麼？	(A) 立即繼續胸外按壓 (B) 立即檢查頸動脈脈搏 (C) 等待機器再次分析 (D) 先給兩次人工呼吸 【解析】電擊剛結束時心肌常處於心肌頓抑狀態，即使電擊成功心臟也無法立刻產生有效搏出量。指引規定「電擊後立即接續 CPR」，連續按壓 2 分鐘後，AED 才會自動進行下一次心律分析。 參考：AHA 心肺復甦術指引 / 消防署教材	(A)
051. 心室纖維顫動的傷患如果沒有接受 CPR，電擊每延遲 1 分鐘，存活率大約下降多少？	(A) 1～2% (B) 3～4% (C) 7～10% (D) 15～20% 【解析】醫學統計顯示，VF 發生後若完全未實施 CPR，每延遲 1 分鐘電擊，存活率急速下降約 7%～10%；若有持續實施高品質 CPR，可將存活率下降速度減緩至每分鐘約 3%～4%。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - OHCA存活率曲線	(C)
052. 清醒的成年男性用餐時突然雙手掐住喉嚨、發不出聲音也無法咳嗽，應優先採取哪一種處置？	(A) 用手指伸進口腔深處挖取 (B) 站到身後實施腹部推擠 (C) 讓他喝水把異物沖下去 (D) 讓他平躺後開始胸外按壓 【解析】清醒成人嚴重異物哽塞首選為哈姆立克法：施救者站於傷患身後，一腳成弓箭步置於傷患兩腳間，一手握拳將拇指側抵於肚臍上方與劍突下方之間，另一手包覆拳頭，快速向後向上連續推擠，直到異物排出或患者昏迷。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 異物哽塞處置	(B)
053. 異物哽塞的病患是懷孕後期的孕婦或過度肥胖者時，應改用哪一種方法？	(A) 胸部推擠法 (B) 背部拍擊法 (C) 腹部推擠法 (D) 手指挖除法 【解析】孕婦或過度肥胖者無法環抱腹部或腹部推擠恐壓迫子宮胎兒，施救者應改站於患者背後，雙手環抱其胸部，置於胸骨下半段實施「胸部推擠法」。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 特殊族群異物哽塞	(A)
054. 異物哽塞的病患在處置中失去意識倒地，施救者接下來應怎麼做？	(A) 扶起病患，繼續腹部推擠 (B) 讓病患平躺，開始胸外按壓 (C) 讓病患側躺，等待自行清醒 (D) 讓病患平躺，改做背部拍擊 【解析】異物哽塞患者一旦失去反應倒地，處置流程立即轉為「無意識 CPR」：胸外按壓 30 次能產生高於腹部推擠的胸內壓；在打開呼吸道給予吹氣前，先檢視口腔，若看見鬆脫之異物才用手指取出，看不見嚴禁盲挖，隨後給予吹氣並持續 CPR。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 哽塞昏迷處置	(B)

題目	選項與法規解析	答案
055. 未滿 1 歲的清醒嬰兒發生嚴重異物哽塞時，應如何處置？	(A) 拍背 5 下與壓腹 5 下交替 (B) 拍背 2 下與壓胸 15 下交替 (C) 拍背 5 下與壓胸 5 下交替 (D) 壓腹 5 下與壓胸 5 下交替 【解析】嬰兒內臟肝臟脆弱，嚴禁實施腹部推擠。正確手法為：固定嬰兒下巴保持頭低腳高趴在施救者前臂上，在兩肩胛骨間「拍背 5 次」；隨後翻轉成面朝上，以兩指在胸骨按壓處「壓胸 5 次」，交替進行直至異物排出或昏迷。 參考：AHA 兒科基礎救命術 / 消防署教材	(C)
056. 傷患胸前皮下有心律調節器的凸起時，AED 貼片應怎麼貼？	(A) 直接貼在凸起處的上方 (B) 不貼貼片，只做胸外按壓 (C) 兩片都改貼在背部 (D) 避開凸起處，貼在旁邊 【解析】若貼片直接貼在節律器硬塊上方，電流會被節律器金屬吸收減弱且可能損壞儀器。正確做法為避開突起部位，距離至少 1 吋（2.5cm）以上貼附。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - AED特殊情境處置	(D)
057. 外傷初級評估 XABCDE 中的 X 代表什麼？	(A) 檢查瞳孔反應 (B) 測量血氧濃度 (C) 處置大量出血 (D) 評估頸椎損傷 【解析】消防署 114 年《救護技術員教科書》電子書第 206 頁：外傷初評的 X 先查看並處置立即可見且持續的大量外出血，再依序評估意識、呼吸道、呼吸、循環等。 參考：消防署《救護技術員教科書》114 年版，電子書第 206 頁	(C)
058. 四肢動脈大量出血，直接加壓無法止血時，應採取哪一種方法？	(A) 在傷口遠心端綁止血帶 (B) 用清水持續沖洗傷口 (C) 抬高患肢並持續冰敷 (D) 在傷口近心端綁止血帶 【解析】消防署 114 年《救護技術員教科書》電子書第 142 頁：危及生命的四肢出血可及早使用止血帶，置於傷口近心端 5 至 8 公分；止血後記錄時間並確認遠端脈搏。 參考：消防署《救護技術員教科書》114 年版，電子書第 142 頁	(D)
059. 為傷患綁上止血帶之後，應遵守哪一項原則？	(A) 用衣物蓋住止血帶保持清潔 (B) 綁到遠端仍摸得到脈搏即可 (C) 記錄使用時間，不自行鬆開 (D) 每 15 分鐘鬆開一次再綁緊 【解析】止血帶應記錄施打時間並讓接手醫護人員看見；在院前救護過程中避免自行鬆開，以免再次大量出血。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 止血帶安全原則	(C)
060. 頭部外傷病患出現雙眼眶周圍瘀青（熊貓眼）或耳後瘀斑，最可能是哪一種骨折？	(A) 頸椎骨折 (B) 顴骨骨折 (C) 顱底骨折 (D) 鼻骨骨折 【解析】耳後瘀斑與雙眼眶瘀青（Raccoon eyes/熊貓眼）加上鼻漏/耳漏腦脊髓液，為典型「顱底骨折」晚期徵兆，嚴禁使用鼻咽呼吸道。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 頭部創傷評估	(C)
061. 胸部穿刺傷造成開放性氣胸時，敷料應如何固定？	(A) 三邊貼緊，留一邊不貼 (B) 只貼一邊，其餘不貼 (C) 兩邊貼緊，留兩邊不貼 (D) 四邊貼緊，完全密封 【解析】開放性氣胸會隨呼吸吸入空氣進入胸膜腔。現場應使用不透氣敷料製作「三邊封閉單向閥」：吸氣時敷料貼緊阻止外界空氣吸入；呼氣時開放的一邊可讓胸膜腔內多餘氣體逸出，防止演變為致命的張力性氣胸。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 胸部創傷處置	(A)

題目	選項與法規解析	答案
062. 腹部外傷造成腸子等臟器外露時，現場應如何處置？	(A) 用乾的紗布直接加壓 (B) 戴手套把臟器推回腹腔 (C) 用彈性繃帶緊緊纏住 (D) 用濕的無菌敷料覆蓋 【解析】脫出之內臟組織嚴禁塞回腹腔（會帶入細菌引起嚴重腹膜炎且造成腸道扭轉壞死）。應用生理食鹽水沾濕之無菌敷料覆蓋保持濕潤，外覆保鮮膜或無菌塑膠布避免水分散失與失溫，雙膝微彎減輕腹壁張力送醫。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 腹部創傷處理	(D)
063. 異物刺入傷患體內並留在傷口上時，現場應如何處置？	(A) 固定異物，不要拔除 (B) 輕輕轉動以確認深度 (C) 立即拔除後加壓止血 (D) 往內推入以減少晃動 【解析】穿刺物在體內常壓迫破損血管形成暫時止血塞，一旦拔除會引發不可收拾的噴射性大出血致死。救護員除「刺穿臉頰阻塞呼吸道」或「穿刺物妨礙實施胸外 CPR 按壓」極罕見情況外，一律「嚴禁拔除」，應就地穩固固定包紮。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 穿刺傷處置	(A)
064. 手指完全截斷時，斷肢應如何保存後送？	(A) 乾紗布包裹後裝袋，保持常溫 (B) 濕紗布包裹後裝袋，再放入冰水 (C) 直接浸泡在生理食鹽水或冰水 (D) 濕紗布包裹後，直接埋進冰塊 【解析】斷肢切忌直接泡水或接觸冰塊，否則組織會細胞凍傷水腫壞死無法再植。正確為「隔水冷藏」：濕紗布包裹 ➔ 放入密封防水袋 ➔ 放入冰水混合容器（約4°C）。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 斷肢保存處置	(B)
065. 以夾板固定長骨骨折時，固定範圍應包含哪些部位？	(A) 骨折處與下方一個關節 (B) 骨折處與上下兩個關節 (C) 骨折處與上方一個關節 (D) 只需固定骨折處本身 【解析】骨幹骨折（如小腿脛腓骨骨折）之固定原則為：夾板必須跨越並固定「骨折處上方的膝關節」與「下方的踝關節」，才能徹底防止斷骨扭轉刺穿肌肉與血管。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 骨折固定基本原則	(B)
066. 夾板固定之前與之後，都要評估肢體末端的哪三項？	(A) 脈搏、血壓與體溫 (B) 膚色、瞳孔與意識 (C) 循環、感覺與運動 (D) 疼痛、腫脹與變形 【解析】固定前與固定後均需檢查 CMS（或稱 PMS）：C（Circulation 脈搏/微血管充填）、M（Motor 腳趾/手指能否活動）、S（Sensory 觸摸有無知覺）。固定後若 CMS 消失，代表包紮過緊阻斷血流，必須立刻重新鬆解調整。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 骨折包紮檢測	(C)
067. 量測硬式頸圈尺寸時，要量病患哪一段的距離？	(A) 下顎到肩膀的距離 (B) 耳垂到肩膀的距離 (C) 後腦到肩膀的距離 (D) 喉結到鎖骨的距離 【解析】頸圈量取法：將頭頸維持中立，以手指垂直測量「下巴下緣假想線」到「斜方肌前緣（肩線）」的手指數（如3指幅），再將此指幅對齊頸圈塑膠片與下緣調整卡榫。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 頸圈量測與穿戴技術	(A)
068. 用長背板固定傷患時，軀幹與頭部的固定順序為何？	(A) 先固定雙腳，最後固定軀幹 (B) 先固定頭部，最後固定雙腳 (C) 先固定頭部，最後固定軀幹 (D) 先固定軀幹，最後固定頭部 【解析】上長背板黃金原則：「先軀幹後頭部」。若先固定頭部，在翻動或搬運綁紮胸髖時，身體軀幹晃動會以已固定的頭部為支點造成嚴重二次頸椎神經拉扯斷裂。故頭頸固定墊一律最後上膠帶固定。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 長背板上板順序	(D)

題目	選項與法規解析	答案
069. 高處墜落的清醒傷患主訴頸部劇痛，救護員接觸傷患的第一個動作是什麼？	(A) 先量血壓與脈搏 (B) 扶傷患坐起檢查 (C) 用雙手固定頭頸部 (D) 請傷患轉動頸部 【解析】懷疑脊椎創傷時，第一步即為「徒手頸椎固定（MILS）」，以雙手固定頭部於自然中立位，直到上好硬頸圈並在長背板上完成頭部固定器固定為止。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 脊椎限制評估	(C)
070. 在狹窄的公寓樓梯間搬運清醒、呼吸困難且沒有頸椎外傷的病患，最適合用哪一種器材？	(A) 長背板 (B) 鏟式擔架 (C) 籃式擔架 (D) 樓梯椅 【解析】搬運椅專為狹窄樓梯設計，病患採坐姿不僅利於心衰氣喘患者呼吸，且在轉角處容易轉向行進，大幅提升安全與搬運效率（但有頸椎創傷疑慮者嚴禁使用搬運椅）。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 搬運器材選擇	(D)
071. 車禍現場車輛起火，單一救護員必須立刻把失去意識的傷患移出車外，應採用哪一種方式？	(A) 緊急拖拉法移出 (B) 等支援到場再移出 (C) 上頸圈固定後移出 (D) 穿脫困背心後移出 【解析】環境有立即爆炸、起火或坍塌危險時，生命優先於常規脊椎限制。應採用緊急移位法（如腋下拖拉或衣領拖拉法），沿身體長軸將傷患以最快速度拖離危險現場至安全地帶再行急救。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 緊急搬運時機	(A)
072. 辛辛那提到院前腦中風評估包含哪三項？	(A) 瞳孔大小、對光反射、眼球偏移 (B) 劇烈頭痛、噴射嘔吐、頸部僵硬 (C) 意識程度、肢體感覺、步態平衡 (D) 臉部下垂、手臂無力、言語異常 【解析】辛辛那提中風評估觀察顏面、手臂與言語三項。任何一項新發異常都應記錄最後正常時間，儘速啟動後送與中風通報；此工具不能單獨確診或排除中風。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 腦中風院前評估	(D)
073. 急性心肌梗塞最典型的胸痛表現是什麼？	(A) 胸口刺痛，深呼吸或按壓時加劇 (B) 胸背撕裂痛，兩手血壓相差很大 (C) 上腹灼熱感，進食後會明顯緩解 (D) 胸口悶壓感，可延伸到左臂或下顎 【解析】典型缺血性心絞痛/心肌梗塞常表現為胸骨後擠壓窒息感、大汗淋漓、呼吸困難，並往左上肢、頸部、下頜輻射。休息或含 NTG 往往無法完全緩解，屬於重大內科危急急症。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 急性冠心症評估	(D)
074. 糖尿病病患低血糖但意識清楚、能吞嚥時，現場應先如何處置？	(A) 給予口服糖水或含糖食物 (B) 讓病患平躺並抬高下肢 (C) 協助施打自備的胰島素 (D) 禁食並給予大量白開水 【解析】意識清楚且能吞嚥的低血糖病患，依「15-15 法則」，立即口服給予約 15 克快速吸收糖類（如半杯果汁或3-4顆方糖），15分鐘後複測血糖。若意識不清或無法吞嚥則嚴禁口服給糖以防窒息。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 糖尿病急症處置	(A)
075. 糖尿病病患意識昏迷、呼喚沒有反應時，下列哪一項處置不可以做？	(A) 由口餵食糖水或食物 (B) 監測血糖與生命徵象 (C) 採復甦姿勢儘速送醫 (D) 維持呼吸道並給氧 【解析】昏迷病患咽喉反射消失，若強行由口餵食糖水或液體，糖水會直接嗆入氣管造成致命性「吸入性肺炎」或呼吸道完全窒息死亡！ 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 糖尿病安全處置禁忌	(A)

題目	選項與法規解析	答案
076. 氣喘或慢性阻塞性肺病急性發作時，聽診最常聽到哪一種呼吸音？	(A) 哮鳴音 (B) 摩擦音 (C) 打鼾音 (D) 濕囉音 【解析】氣喘發作時小支氣管平滑肌痙攣狹窄與黏膜水腫，氣流呼出受阻形成高音頻的連續性「呼氣喘鳴音」，病患常呈端坐呼吸。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 呼吸急症聽診	(A)
077. 嚴重過敏性休克合併喉頭水腫與低血壓時，首選的救命藥物是什麼？	(A) 硝化甘油 (B) 抗組織胺 (C) 阿斯匹靈 (D) 腎上腺素 【解析】過敏性休克第一線救命藥物為肌肉注射 Epinephrine (1:1000, 劑量成人0.3-0.5mg)。若病患隨身攜帶醫師開立之 EpiPen（筆型自動注射器），EMT-1 得依指引協助病患注射於大腿外側中段。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 過敏性休克處置	(D)
078.「休克」指的是什麼？	(A) 腦部的血流突然增加 (B) 心跳的速率低於正常 (C) 血液中的含氧量過高 (D) 組織的血液灌流不足 【解析】休克在醫學上並非心理嚇到，而是指心血管循環衰竭，造成「全身微循環灌流不足」，組織細胞無法獲得足夠氧氣及養分，引發無氧呼吸、乳酸中毒與多重器官衰竭。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 休克病理定義	(D)
079. 出血性休克的傷患，如果沒有頭部、胸部或脊椎外傷，現場通常採取哪一種姿勢？	(A) 平躺並抬高下肢 (B) 半坐臥並屈膝 (C) 俯臥並墊高胸部 (D) 側躺採復甦姿勢 【解析】單純低血容/失血性休克，將病患平躺並抬高下肢 20～30 公分（約8-12吋），可利用重力增加下肢靜脈血液回流心臟（Autotransfusion 約300-500ml），提升心輸出量與重要器官灌流。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 休克體位處置	(A)
080. 疑似急性心肌梗塞併發肺水腫、呼吸困難的病患，不適合採取哪一種姿勢？	(A) 病患自覺舒適的坐姿 (B) 平躺並抬高下肢 (C) 半坐臥並墊高背部 (D) 坐姿並身體前傾 【解析】心因性休克合併急性肺水腫時，心臟收縮力已衰竭，若抬高下肢會使大量靜脈血湧回心臟（增加前負荷 Preload），直接造成急性心衰竭肺積水溺死！此類病患應採「半坐臥姿」，減少回心血量並利於橫膈呼吸。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 心因性急症禁忌	(B)
081. 依成人九則計算法，整個頭頸部與單側下肢各占體表面積多少？	(A) 頭頸部 18%，單側下肢 18% (B) 頭頸部 18%，單側下肢 9% (C) 頭頸部 9%，單側下肢 9% (D) 頭頸部 9%，單側下肢 18% 【解析】成人九則：頭頸部 9%；雙上肢各 9%（共18%）；前軀幹 18%、後軀幹 18%（軀幹共36%）；雙下肢各 18%（單側下肢前9%+後9%=18%，雙下肢共36%）；會陰生殖器 1%。總和為 100%。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 燒燙傷面積計算	(D)
082. 燒燙傷部位紅腫、劇痛並起水泡，深度屬於哪一級？	(A) 一度 (B) 二度 (C) 三度 (D) 四度 【解析】一度傷及表皮（紅腫乾熱疼痛，如日曬）；二度傷及真皮層（起水泡、劇痛、紅腫滲出液）；三度傷及全層皮膚（焦黑、皮革狀或蒼白，神經壞死痛覺消失）。現場切勿刺破水泡！ 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 燒傷分度判定	(B)

題目	選項與法規解析	答案
083. 燙傷處理口訣「沖、脫、泡、蓋、送」中的「沖」，正確做法是什麼？	(A) 用溫熱的清水沖洗傷處 (B) 用流動的冷水沖洗傷處 (C) 用冰塊直接敷在傷處 (D) 用生理食鹽水擦拭傷處 【解析】沖水應以溫和流動冷水沖洗 15～30 分鐘以帶走餘熱。嚴禁直接用冰塊冰敷（會造成微血管收縮壞死與組織凍傷加深傷度），嚴禁塗抹醬油、牙膏、草藥等偏方造成感染。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 燒燙傷急救五步驟	(B)
084. 區分熱衰竭與熱中暑，最關鍵的指標是什麼？	(A) 是否有心跳加快 (B) 是否有肌肉抽筋 (C) 是否仍大量流汗 (D) 是否有意識改變 【解析】高溫環境下出現意識混亂、抽搐或昏迷等中樞神經異常，應高度懷疑熱中暑並立即降溫、送醫。病患仍可能流汗，不能以是否無汗作為排除標準。 參考：美國 CDC／NIOSH 熱傷害資訊	(D)
085. 熱中暑昏迷的傷患，現場最重要的處置是什麼？	(A) 儘快為身體降溫 (B) 先測量血糖數值 (C) 蓋毛毯避免失溫 (D) 由口補充電解質水 【解析】熱中暑是時間與溫度的賽跑！關鍵為「快速積極降溫」：移至陰涼處、解開衣物、以冷水/濕毛巾噴灑皮膚並輔以電扇強風快速吹拂促進蒸發散熱，並在頸部、腋下、鼠蹊部置放冰袋，目標是盡快將核心體溫降至 38.5°C 以下。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 熱急症急救技術	(A)
086. 遭毒蛇咬傷時，下列哪一項處置是錯誤的？	(A) 保持冷靜減少活動 (B) 取下患肢的戒指手錶 (C) 記下蛇的外觀特徵 (D) 切開傷口吸出毒液 【解析】切開傷口易傷及神經血管並加速毒素擴散；用嘴吸吮會使施救者經口腔黏膜中毒；冰敷會造成組織壞死；緊縛止血帶會阻斷動脈引發肢體缺血壞疽。這些傳統偏方全部嚴格禁止！ 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 動物咬傷處置	(D)
087. START 檢傷分類的第一步是請能自行走動的傷患到指定區域集合，這些傷患歸為哪一種顏色？	(A) 綠色 (B) 紅色 (C) 黑色 (D) 黃色 【解析】START 檢傷第一步即廣播：「所有能站立並自行行走的傷患請跟著救護員移動至綠區集合」。能自行走動代表呼吸、循環、神經功能尚可自理，全部分類為「綠色（輕傷/走動傷患）」。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - START檢傷分類法	(A)
088. START 檢傷分類中，傷患沒有呼吸，暢通呼吸道後仍然沒有呼吸，應歸為哪一種顏色？	(A) 黃色 (B) 黑色 (C) 綠色 (D) 紅色 【解析】大量傷患災難現場醫療資源有限。無呼吸者經單純暢通呼吸道後若仍無自主呼吸，直接歸為「黑色標籤」，現場不進行 CPR 按壓，以將有限資源保留給有存活希望的紅黃傷患。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - START決策流程	(B)
089. START 檢傷分類中，原本沒有呼吸的傷患在暢通呼吸道後恢復呼吸，應歸為哪一種顏色？	(A) 黃色 (B) 綠色 (C) 黑色 (D) 紅色 【解析】暢通呼吸道後立刻恢復自主呼吸，代表氣道可逆且急需維持，直接跳過後續評估，立即判定為「紅色（第一優先/極重傷）」，優先搶救運送！ 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - START評估流程圖	(D)

題目	選項與法規解析	答案
090. START 檢傷分類中，不能走動的傷患呼吸速率每分鐘超過幾次，就直接歸為紅色？	(A) 10 次 (B) 20 次 (C) 30 次 (D) 40 次 【解析】START 檢傷口訣「RPM」（Respiration 呼吸、Perfusion 灌流、Mental 意識）。呼吸速率 ＞ 30 次/分（或 ＜ 10 次/分）代表嚴重呼吸衰竭或換氣過度，直接判定為「紅色」。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - START呼吸指標	(C)
091. START 檢傷分類中，傷患呼吸每分鐘 22 次，但摸不到橈動脈脈搏，應歸為哪一種顏色？	(A) 黃色 (B) 綠色 (C) 紅色 (D) 黑色 【解析】無橈動脈或 CRT ＞ 2 秒代表病患處於嚴重休克或周邊循環衰竭，直接判定為「紅色標籤（極重傷）」，應立即控制可見大出血並優先後送。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - START循環指標	(C)
092. START 檢傷分類中，傷患呼吸每分鐘 20 次、橈動脈脈搏明顯、微血管充填時間少於 2 秒，但無法聽從簡單指令，應歸為哪一種顏色？	(A) 綠色 (B) 黃色 (C) 紅色 (D) 黑色 【解析】RPM 第三步 Mental Status（意識）：無法遵循簡單指令代表中樞神經嚴重受損或嚴重缺氧昏迷，直接歸為「紅色標籤」。若能聽從指令但因骨折無法走動，則歸為「黃色標籤」。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - START意識評估	(C)
093. 傷患大腿骨折無法行走，呼吸每分鐘 18 次、橈動脈脈搏正常、微血管充填時間 1.5 秒、能聽從指令，START 檢傷應歸為哪一種顏色？	(A) 紅色 (B) 黑色 (C) 黃色 (D) 綠色 【解析】不能走動但呼吸、循環、意識三大指標均正常穩定，無立即致命性傷害，判定為「黃色標籤（第二優先中度傷患）」，可暫緩後送，待紅色傷患運送完畢後處理。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 黃色檢傷標準	(C)
094. 大量傷病患現場以 START 檢傷時，每位傷患的評估時間原則上應在多久以內？	(A) 1 分鐘 (B) 3 分鐘 (C) 5 分鐘 (D) 10 分鐘 【解析】大量傷病患檢傷強調「快速分流」。檢傷人員不進行耗時的包紮或心電圖檢查，僅快速依 RPM 判定等級並繫上標籤，每位傷患評估時間嚴格控制在「30 秒至 1 分鐘內」，才能快速掌握全場傷亡輪廓。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 檢傷時效控制	(A)
095. 救護技術員抵達事故現場，接近傷患之前的第一件事是什麼？	(A) 確認現場環境安全 (B) 回報指揮中心到達 (C) 準備急救器材下車 (D) 確認傷患人數多寡 【解析】救護安全三大守則：1. 我最重要；2. 夥伴安全；3. 病人安全。沒有安全的救護員就沒有安全的病患。抵達現場首重「現場安全評估」，確認無危險且穿妥防護裝備（PPE）方可進入。 參考：消防署初級救護技術員訓練教材 - 現場安全與自我保護	(A)
096. 依《緊急醫療救護法》第32條，直轄市、縣（市）政府遇大量傷病患或野外緊急救護時，應依災害規模及種類建立什麼，以施行救護有關工作？	(A) 災害物資調度系統 (B) 現場指揮協調系統 (C) 現場傷病登錄系統 (D) 後送醫院轉診系統 【解析】《緊急醫療救護法》第32條：直轄市、縣（市）政府遇大量傷病患或野外緊急救護，應依災害規模及種類，建立現場指揮協調系統，施行救護有關工作。第33條並規定參與現場急救的救護人員及救護運輸工具設置機關（構），均應依現場指揮協調系統之指揮施行救護。 參考：緊急醫療救護法 第32條	(B)